

Estrés Agudo y Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)

1. Introducción y relevancia clínica

El **Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)** es una condición psiquiátrica que aparece tras la exposición a un **evento traumático extremo**, como amenaza real de muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea **vivido directamente, presenciado o conocido**.

El **trastorno de estrés agudo (TEA)** es una reacción similar, pero **transitoria (dura menos de 1 mes)**, mientras que el TEPT se diagnostica cuando los síntomas persisten **más de 1 mes**.

En Chile, el TEPT tiene una alta prevalencia tras **catástrofes naturales, violencia intrafamiliar y trauma laboral (Carabineros, personal de salud, víctimas de abuso o accidentes)**.

Afecta entre **3 y 7% de la población**, y hasta un **30% en poblaciones expuestas a traumas severos**.

- En el **EUNACOM**, las preguntas más frecuentes incluyen:
 - Diferencias entre estrés agudo, TEPT y adaptación.
 - Criterios diagnósticos según DSM-5.
 - Tratamiento psicoterapéutico (TCC enfocada en trauma) y farmacológico (ISRS).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El TEPT es una respuesta patológica al trauma, donde **la memoria emocional del evento no se integra correctamente**, permaneciendo como una experiencia vívida, intrusiva y reexperimentada.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Amígdala hiperactiva:** genera respuesta exagerada de miedo y hipervigilancia.
- **Hipocampo disminuido:** altera la codificación del recuerdo y su contextualización temporal ("siento que vuelve a ocurrir").
- **Corteza prefrontal medial hipoactiva:** incapaz de modular la respuesta emocional.

- **Eje hipotálamo–hipófiso–adrenal (HHA):** disfunción en el feedback del cortisol → hipersecreción inicial y posterior agotamiento.

2.2. Factores predisponentes

- Trauma severo, prolongado o interpersonal (abuso, violación).
- Historia de trauma infantil o negligencia.
- Falta de apoyo social posterior al evento.
- Comorbilidad psiquiátrica previa (depresión, ansiedad, abuso de sustancias).
- Rasgos de personalidad evitativa o dependiente.

2.3. Diferencia entre memoria adaptativa y patológica

- En el estrés normal, el recuerdo traumático se **integra** al sistema de memoria autobiográfica.
 - En el TEPT, la memoria queda **fragmentada y sensorial**, generando flashbacks e hiperalerta crónica.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Criterios diagnósticos (DSM-5)

A. Exposición a un evento traumático:

- Experiencia directa, testigo o conocimiento de un hecho violento o mortal.

B. Síntomas intrusivos (≥1):

- Recuerdos o imágenes recurrentes, involuntarias.
- Sueños angustiosos relacionados.
- **Flashbacks** (revivir el evento).
- Malestar intenso ante estímulos que recuerdan el trauma.

C. Evitación persistente (≥ 1):

- Evitar pensamientos, conversaciones o lugares asociados.

D. Alteraciones negativas en cognición o ánimo (≥ 2):

- Amnesia disociativa parcial del evento.
- Culpa, vergüenza o emociones negativas persistentes.
- Pérdida de interés o desconexión afectiva.
- Sentimiento de desapego o visión pesimista del futuro.

E. Alteraciones del estado de alerta (≥ 2):

- Irritabilidad, estallidos de ira.
- Hipervigilancia, sobresalto exagerado.
- Insomnio o dificultad de concentración.

Duración:

- ≥ 1 mes.
 - Causa malestar o deterioro funcional significativo.
-

3.2. Trastorno de Estrés Agudo (TEA)

Síntomas similares al TEPT, pero:

- **Duración:** entre **3 días y 1 mes** tras el evento.
 - **Síntomas disociativos** más prominentes (despersonalización, irrealidad).
 - Si persiste >1 mes $\rightarrow$ se considera TEPT.
-

3.3. Trastorno de adaptación

- Ocurre ante un **evento estresante no extremo** (duelo, separación, despido).
- Aparece dentro de los **3 meses posteriores** y se resuelve antes de 6 meses.
- No cumple criterios de trauma grave ni síntomas de reexperimentación.

□ **EUNACOM:** distinguir TEA / TEPT / adaptación según intensidad del evento y duración de síntomas.

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Clave diferencial
Depresión mayor	Ánimo bajo constante, sin reexperimentación ni hipervigilancia.
TAG	Ansiedad difusa sin trauma identificable.
Trastorno disociativo	Desconexión de identidad o memoria, sin recuerdos intrusivos.
Esquizofrenia	Alucinaciones sin relación con evento traumático.
TEA vs TEPT	<1 mes vs >1 mes.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en la historia y síntomas característicos.

Se pueden utilizar herramientas de apoyo:

- **Escala CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale):** patrón de referencia para diagnóstico y seguimiento.
- **PCL-5 (PTSD Checklist):** autoinforme útil para cribado.

- **Escala de Impacto de Evento-Revisada (IES-R):** mide intrusión, evitación y activación.

Exámenes de laboratorio: no específicos, pero útiles para descartar comorbilidades:

- TSH, glicemia, perfil hepático (antes de ISRS).
 - Alcohol y drogas en sospecha de abuso asociado.
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y consensos internacionales)

El abordaje debe ser **multidimensional y escalonado**, centrado en **psicoterapia y farmacoterapia según la gravedad**.

5.1. Intervención inicial (primeras 72 h tras trauma)

- **Apoyo psicológico de contención:** escucha activa, validar emociones.
 - Evitar interrogatorios forzados o detalles traumáticos (“debriefing” no recomendado).
 - Control del entorno: seguridad, descanso, apoyo familiar.
 - En casos severos → derivar a salud mental.
-

5.2. Psicoterapia

a. Primera línea: Terapia Cognitivo-Conductual enfocada en trauma (TCC-T)

- **Exposición prolongada:** revivir el recuerdo en ambiente seguro para disminuir la evitación.
- **Reestructuración cognitiva:** identificar y modificar creencias disfuncionales (“fue mi culpa”, “nunca estaré a salvo”).
- **Entrenamiento en relajación y regulación emocional.**
- **Prevención de recaídas y afrontamiento.**

- ☐ Es la **terapia con mayor evidencia** tanto en TEA como en TEPT.
-

b. Otras opciones psicoterapéuticas

- **EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares):** validada por la OMS y guías MINSAL para trauma psicológico.
 - **Terapia de exposición narrativa o grupal** en contextos de catástrofe.
 - **Terapia de apoyo interpersonal** en casos leves.
-

5.3. Farmacoterapia

Primera línea: ISRS

- **Sertralina** 50–200 mg/día
- **Paroxetina** 20–60 mg/día
- **Fluoxetina** 20–80 mg/día
- **Escitalopram** 10–20 mg/día

- ☐ Mejoran ansiedad, insomnio, hipervigilancia y disforia.

- ☐ Mantener por **12–18 meses** tras remisión.

Segunda línea: IRSNa (Venlafaxina XR)

- 75–225 mg/día, útil si hay pobre respuesta a ISRS.

Fármacos adyuvantes:

- **Prazosina:** eficaz para pesadillas y flashbacks (1–5 mg noche).
 - **Antipsicóticos atípicos (quetiapina, risperidona):** en casos con agitación o síntomas psicóticos.
 - **Benzodiacepinas:** evitar salvo en crisis aguda severa (por riesgo de dependencia y empeorar reexperimentación).
-

5.4. Enfoque en el Trastorno de Estrés Agudo (TEA)

- Priorizar **contención y psicoterapia breve de exposición**.
 - ISRS si persisten síntomas >2 semanas o hay alto riesgo de TEPT.
 - Reevaluar a las 4 semanas → si persisten síntomas, reclasificar como TEPT.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Depresión mayor (60%)
- Abuso de alcohol o drogas (hasta 50%)
- Trastornos disociativos
- Conductas suicidas
- Trastornos somatomorfos o del sueño crónico

Pronóstico

- 50–60% logra remisión completa en 1 año.
 - Mejor pronóstico: tratamiento precoz, buen apoyo social, trauma único.
 - Peor pronóstico: trauma interpersonal prolongado, comorbilidad psiquiátrica, ausencia de apoyo familiar.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **TEA:** síntomas <1 mes tras trauma; **TEPT:** >1 mes.

2. **Reexperimentación, evitación e hipervigilancia** son el triángulo diagnóstico.
 3. **TCC-T y EMDR** son terapias de primera línea según MINSAL.
 4. **ISRS (sertralina, paroxetina)** son los fármacos de elección.
 5. Evitar benzodiacepinas: pueden agravar síntomas o generar dependencia.
 6. El **debriefing psicológico** inmediato no previene TEPT y puede ser dañino.
 7. La **prazosina** es útil en pesadillas refractarias.
-



Errores comunes

- Confundir estrés agudo con adaptación leve.
 - Tratar TEPT solo con benzodiacepinas.
 - Interrogar forzosamente sobre el trauma (revictimización).
 - No ofrecer psicoterapia basada en evidencia.
 - Suspender ISRS antes de 6–12 meses.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **TEPT** aparece tras exposición a un trauma extremo, con reexperimentación, evitación y activación persistente.
2. El **estrés agudo** dura menos de 1 mes; si persiste, se reclasifica como TEPT.
3. La **Terapia Cognitivo-Conductual enfocada en trauma (TCC-T)** y el **EMDR** son los tratamientos más eficaces.
4. Los **ISRS (sertralina, paroxetina)** son el manejo farmacológico de elección.
5. **Evitar benzodiacepinas** y el “debriefing” precoz.

6. La **prazosina** puede reducir pesadillas en TEPT.
7. El pronóstico mejora con **detección precoz y apoyo psicosocial**.